ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

CHRU de Nancy

ÉducÉpi

L'éducation thérapeutique en épilepsie



CHRU NANCY

UTEP Unité Transversale d'Éducation thérapeutique du Patient www.chu-nancy.fr

LARA LORRAINE AFFECTIONS RARES

DéfiScience Maladies Rares du Neurodéveloppement FILIÈRE NATIONALE DE SANTÉ

Ce livret a été conçu par une équipe pluridisciplinaire :

Mme Rohrer Ludivine, Infirmière en Pratique Avancée (IPA) Pathologies Chroniques Stabilisées, Coordinatrice du programme d'ETP
Dr Boschetti Emmanuelle, pharmacienne hospitalière
Mme Forthoffer Natacha, neuropsychologue
Mme Thouvenin Dorothée, Infirmière en Pratique Avancée Psychiatrie et Santé Mentale
Dr Bonneville Amélie, pharmacienne hospitalière
Mr Foure Louis, interne en pharmacie
Mme Voyen Madeline, Unité Transversale d'Éducation Thérapeutique (UTEP)
Mme Tahay Constance, UTEP et École Nationale Supérieure d'Art et de Design.
Mme Franc Sherley, UTEP et Master d'ingénierie pédagogique

Conçu pour vous guider tout au long du programme d'Éducation Thérapeutique du Patient atteint d'épilepsie « **ÉducÉpi** », ce livret a pour vocation de résumer les messages importants des différents ateliers. Il constitue une synthèse de l'ensemble de la prise en charge de cette maladie. Vous pourrez vous y référer à la suite des sessions et/ou vous en resservir plus tard.

Durant votre participation au programme, vous ne serez pas amené à suivre tous les ateliers. Ils vous seront proposés selon votre situation particulière, à l'issue du premier échange avec l'Infirmière de Pratique Avancée (IPA) référente.

Les parties du document qui vous concernent vous seront alors remises sous formes de fiches à intégrer. Vous pourrez également y ajouter vos notes personnelles.

Atelier	Intervenant(s)	Date de la séance suivie (à compléter)
GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉPILEPSIE		
ÉPILEPSIE et VIE QUOTIDIENNE		
LE TRAITEMENT ANTI-ÉPILEPTIQUE		
ÉPILEPSIE, DÉPRESSION et ANXIÉTÉ (selon les besoins du patient)		
ÉPILEPSIE et PLAINTE COGNITIVE (selon les besoins du patient)		



1.

Généralités sur l’épilepsie



2.

Épilepsie et vie quotidienne



3.

Traitement anti-épileptique

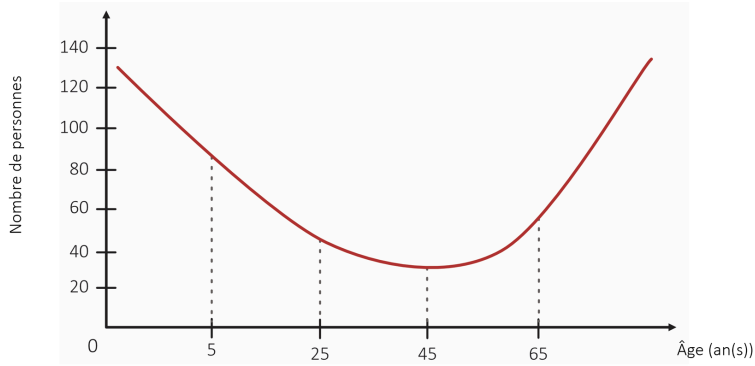
Séance 1
GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉPILEPSIE

Comprendre son épilepsie
Savoir réagir en cas de crise



D'aussi loin que remonte l'histoire, l'épilepsie a existé. Elle a longtemps été méconnue et considérée avec superstition, porteuse de stigmatisation et de préjugés qui persistent encore aujourd'hui.
Et pourtant, certains des personnages célèbres les plus créatifs et talentueux de l'histoire avaient une épilepsie : Jules César, Jeanne d'Arc, Isaac Newton, Molière, Napoléon Bonaparte, Beethoven, Vincent Van Gogh, Agatha Christie…

Environ 650 000 personnes en France présentent une épilepsie (1% de la population). 100 nouveaux cas sont diagnostiqués par jour. L'épilepsie peut apparaître à n'importe quel âge, avec des pics d'apparition dans l'enfance et après 60 ans. Tout le monde peut commencer à faire de l'épilepsie.



Personnes diagnostiquées épileptiques sur 1000 habitants



20% d'enfants



60% d'adultes



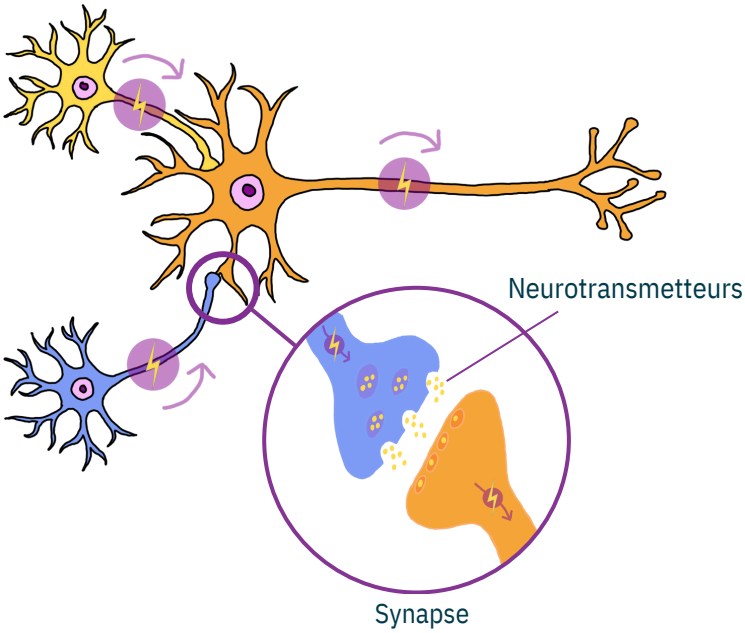
20% de séniors

Les épilepsies peuvent avoir des causes variées : traumatisme crânien, malformation cérébrale, accident vasculaire cérébral, infection (encéphalite, méningite), tumeur, avoir une origine génétique ou n'avoir aucune cause connue (épilepsie dite « idiopathique »).

Ce n'est ni une maladie contagieuse, ni une maladie mentale.

Le fonctionnement du cerveau

Le **cerveau** commande l'ensemble du corps en transmettant des messages électriques le long des **neurones** (cellules dans le cerveau). Cette décharge électrique déclenche la libération de **substances chimiques** (les **neurotransmetteurs**) au niveau des synapses (espace qui relie les neurones) Ce phénomène permet la poursuite du message électrique de neurones en neurones.



La maladie épileptique

L'épilepsie est une **maladie neurologique** due à des **décharges électriques excessives** produites par les neurones, ce qui provoque des **crises**.
On parle d'**épilepsie** ou de **maladie épileptique** lorsqu'il y a **répétition des crises**. C'est donc une **pathologie chronique** dont la crise d'épilepsie est un symptôme.

↳ *Une crise unique ne signifie pas que l'on est épileptique : la maladie épileptique se définit dès lors qu'il existe une répétition de crises ou une forte probabilité qu'elles se répètent.*

Les épilepsies sont classées en **deux** grandes catégories :

- **Généralisée**
  ↳ étendue à toutes les zones du cerveau, comprenant :
    - **Crise généralisée tonico-clonique**
    - **Absence**

- **Focale**
  ↳ limitée à une région précise du cerveau

C'est pourquoi on parle plutôt « **des** épilepsie**S** » au pluriel

Les crises d'épilepsie

Les crises d'épilepsies correspondent à une **décharge électrique soudaine qui se propage dans le cerveau puis qui s'arrête**.
La **fréquence de survenue** des crises varie selon les personnes. Elles peuvent se manifester de façon **pluri-hebdomadaires ou au contraire plus rarement (une fois par an par exemple)**.

En général, la crise d'épilepsie est assez **courte** (moins de deux à trois minutes). Mais dans de rares cas, la crise ne se termine pas. Lorsqu'une crise dure plus de 5 minutes, ou qu'il se produit une **série de crises répétées**, il peut s'agir d'un **état de mal épileptique**. C'est alors une urgence médicale.

Les manifestations de la crise d'épilepsie sont très variables d'une personne à une autre, pouvant aller de **manifestations très subtiles, pratiquement non détectables de l'extérieur** (sensation interne étrange, sensation vertigineuse, perception de mauvais goût, mauvaise odeur, illusion visuelle ou auditive...) **à des manifestations très impressionnantes** comme les convulsions généralisées.

Un patient donné présentera le plus souvent la même succession de symptômes au cours de ses crises. Ces signes seront différents chez un autre patient.



Les cartes photo-langages utilisées pendant la séance d'éducation thérapeutique permettent d'échanger sur vos symptômes spécifiques et possiblement différents pour chacun.

Les différents types de crise

- **La crise généralisée**

Les crises généralisées touchent la **totalité du cerveau**. Il en existe différents types :

- Les **absences** sont une forme de crise généralisée. Elles se manifestent par de brèves ruptures de contact ; la personne est immobile, le regard fixe, ne se rend compte de rien et n'en garde ensuite aucun souvenir. Elles touchent plutôt l'enfant ou l'adolescent. Les crises peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée.

- La **crise généralisée tonico-clonique** reste la plus impressionnante. Elle se manifeste par différentes phases successives :
  - Parfois, elle débute par un cri
  - Perte de connaissance avec chute brutale
  - Raidissement des membres (**= phase tonique**)
  - Mouvements convulsifs, secousses violentes (**= phase clonique**)

Puis, les convulsions s'arrêtent. La crise est alors terminée. La personne peut alors produire un ronflement très bruyant, avoir beaucoup de salive dans la bouche, avoir perdu ses urines ou s'être mordu la langue. Elle reprend connaissance progressivement sans aucun souvenir de la crise. Elle peut être confuse, désorientée, fatiguée et avoir des courbatures. Cette phase peut prendre une trentaine de minutes environ, parfois plus.

- **Crise focale**

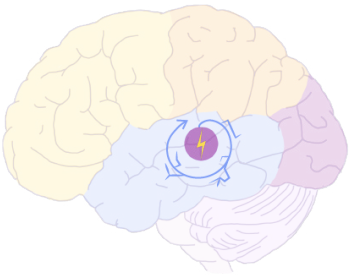
Les crises focales débutent dans **une région du cerveau.** Les symptômes varient en fonction de la région impliquée car chaque région du cerveau participe à des fonctions particulières.

Exemple selon la localisation de la décharge électrique :

- Région responsable de la vision
  - ↳ Perception de flash lumineux
- Région sensitive
  - ↳ Perception de fourmillements au niveau du bras ou de la jambe
- Région motrice
  - ↳ Soubresauts au niveau d'un membre (clonies), raideur

Parfois, quand l'épilepsie est mal contrôlée, cette crise focale va se propager dans le cerveau et généraliser dans un deuxième temps. Cela peut être tellement rapide que les symptômes précédents ne seront alors pas détectables et les symptômes constatés par la famille seront ceux de la crise généralisée tonico-clonique.

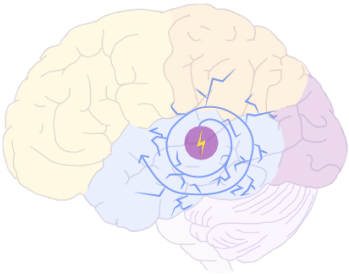
CRISE FOCALE



CRISE FOCALE



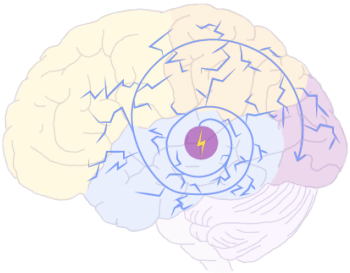
PROPAGATION DE LA CRISE



PROPAGATION DE LA CRISE



CRISE GÉNÉRALISÉE



CRISE GÉNÉRALISÉE



Que doit-on faire quand une personne présente une crise d'épilepsie ?

• Garder son calme
• Si possible, aider la personne lors de la chute en l'accompagnant vers le sol
• Notez l'heure précise du début de la crise
• Dégagez l'espace autour de la personne et écartez les objets dangereux qui pourraient la blesser
• Protégez sa tête en plaçant un coussin ou un vêtement replié
• Desserrez ses vêtements, col, ceinture, enlevez ses lunettes
• Dès la fin des convulsions, allongez la personne sur le côté en Position Latérale de Sécurité
• Attendez qu'elle reprenne complétement conscience : cela peut prendre 30 minutes à 1 heure pour retrouver son état normal.

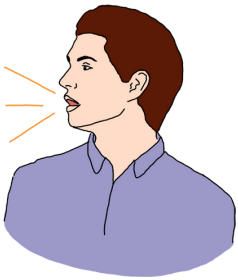
Ce qu'il ne faut pas faire :

• **Ne mettez rien dans sa bouche** et surtout pas vos doigts
• Ne déplacez pas la personne pendant les convulsions, sauf si elle se trouve en danger immédiat (bord de route, escalier, bord de l'eau, proximité immédiate d'un feu ou d'un radiateur brûlant...)
• Ne bloquez pas ses mouvements, n'essayez pas de l'asseoir ou de la contenir
• N'essayez pas de donner de médicament tant que la crise se déroule (sauf médicament d'urgence ordonné par une prescription médicale)
• Ne donnez rien à boire, ni à manger

Vous pouvez photocopier la page suivante pour la distribuer aux personnes de votre entourage, afin qu'elles sachent comment réagir si elles sont présentes lors d'une crise.

PHASES DE LA CRISE GÉNÉRALISÉE TONICO-CLONIQUE

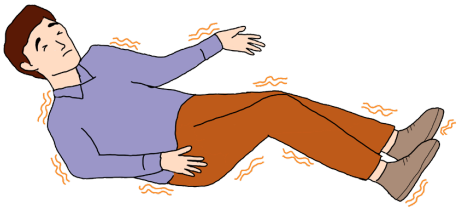
Parfois, cri/râle/ vocalisation 1





2 La personne devient raide = phase tonique, puis elle chute, essayez si possible de la rattraper

Convulsion = phase clonique 3



PRISE EN CHARGE D'UNE CRISE

Gardez votre calme et rassurez la personne qui fait la crise sans restreindre ses mouvements



Chronométrez et noter la durée de la crise



Écartez les meubles de la personne qui fait la crise

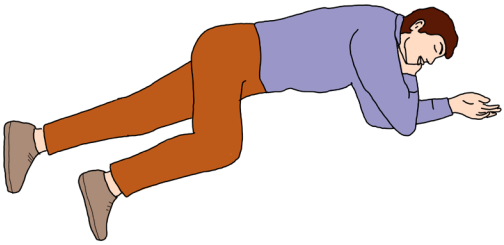
Mettre quelque chose sous la tête de la personne





NE RIEN METTRE DANS SA BOUCHE

UNE FOIS LA CRISE TERMINÉE



Mettre la personne en
Position Latérale de Sécurité

Attendre que le patient prenne connaissance, cela peut prendre **30 minutes**

Les numéros d'urgence

15 =SAMU

18 = Pompiers

112 = N° d'appel européen

114 = n° SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes

Si les convulsions durent plus de **5 minutes**

Si une 2e crise survient

Si la personne s'est blessée

Les facteurs

S'il est impossible de prévoir l'apparition d'une crise d'épilepsie, il est possible de **réduire leur fréquence** en évitant de s'exposer aux facteurs favorisant leur déclenchement. Toutefois, de nombreuses personnes ne peuvent pas relier leurs crises à des événements particuliers.

Qu'est ce qui peut favoriser la survenue d'une crise d'épilepsie?



- **Oublier son traitement**
- Manquer de sommeil
- Consommer de l'alcool régulièrement ou en qualité déraisonnable



- Prendre des toxiques



- Etre malade, avoir de la fièvre
- Vivre un événement stressant



- Chez certaines femmes, la période des règles peut favoriser les crises



Notez vos crises sur un calendrier et ce qui a pu éventuellement les favoriser.
Cela aidera votre neurologue à mieux vous prendre en charge.

Des cartes « situation » utilisées pendant la séance d'éducation thérapeutique permettent d'échanger sur ces circonstances favorisantes et sur vos expériences personnelles

Le suivi de l'épilepsie :

- **Les examens**

Afin de faire un diagnostic précis et complet de l'épilepsie et de son retentissement, vous serez amené à faire des examens complémentaires :



- EEG = électro-encéphalogramme : autrement dit un enregistrement de l'activité électrique de votre cerveau à la recherche des signes de votre épilepsie



- Bilan Neuropsychologique : une évaluation du fonctionnement habituel de votre cerveau, autrement dit un bilan de votre mémoire, de votre langage, de votre attention etc..



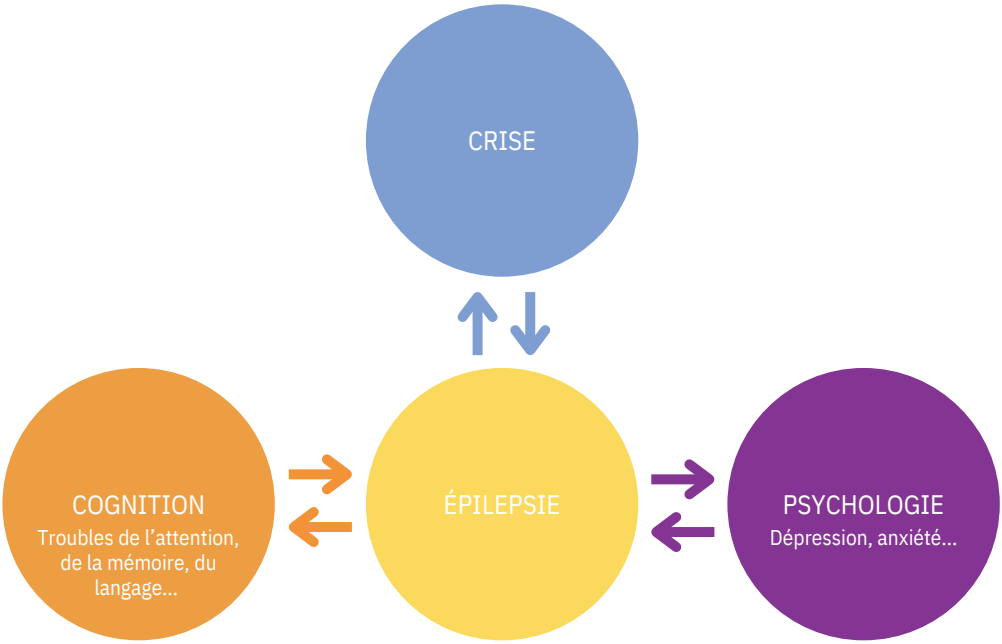
- IRM : imagerie permettant de visualiser une éventuelle malformation pouvant expliquer votre épilepsie

- **Les professionnels de santé qui vous accompagnent**

L'épilepsie nécessite d'être suivi par un médecin spécialiste, le Neurologue, qui interprétera les examens réalisés pour identifier le type d'épilepsie et prescrire le traitement le plus adapté. Vous serez amené à le consulter au moins tous les ans, même en cas d'épilepsie bien stabilisée par les médicaments.

Mais souffrir d'une épilepsie, ce n'est pas seulement faire des crises. Ce sont aussi d'autres manifestations qui font complètement partie de la maladie ou qui peuvent être liées au traitement:

- Avoir parfois des **difficultés de mémoire, d'attention, de langage** (on cherche ses mots, on dit un mot à la place d'un autre...)
- Avoir parfois des **difficultés d'ordre psychologique : dépression, anxiété, angoisse de faire des crises**



D'autres professionnels de santé, **IPA (Infirmière de pratique Avancée), Psychiatres ou encore Neuropsychologue** pourront intervenir dans ces différentes dimensions de la maladie. Des ateliers spécifiques dans le cadre de ce programme d'éducation thérapeutique peuvent vous également vous aider à mieux comprendre votre suivi.

... et tous les autres

L’épilepsie est aussi une maladie très mal connue par le public et à cause de laquelle on peut se sentir isolé.

- En parler autour de soi est très important
- Ne pas hésiter à faire appel aux associations de patients

https://www.efappe.epilepsies.fr

https://www.epilepsie-france.com

https://epilepsies-aege.fr

https://www.youtube.com/watch?v=ZKCWf_vviWw&list=PLsMiiGcYkbgoLwJswBfHSYh_TQr2B6dcm&index=1

https://youtu.be/n42s3HlrSOg

GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉPILEPSIE

Mes notes sur la séance



Séance 2
ÉPILEPSIE ET VIE QUOTIDIENNE

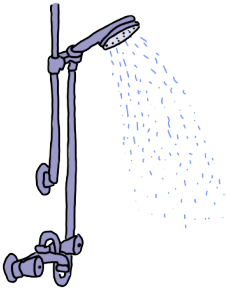
Vivre avec son épilespie



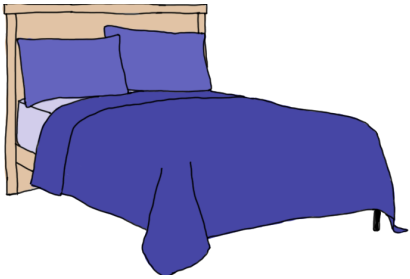
Les retentissements de la maladie sur la vie quotidienne diffèrent selon la nature et la fréquence des crises. Des précautions peuvent être prises pour limiter les risques et vivre avec sa maladie en minimisant son impact.

A la maison

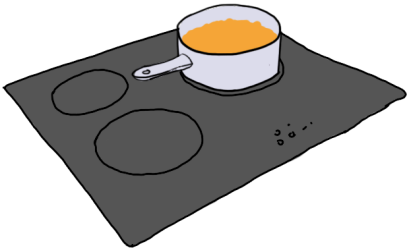
Quelques précautions simples à prendre :



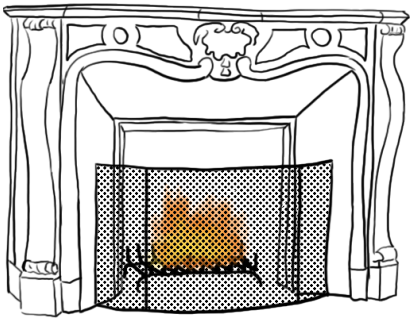
Dans la salle de bains :
Préférez les douches aux bains, évitez de verrouiller la porte



Dans la chambre :
Evitez les coussins ou utilisez un oreiller spécifique



Dans la cuisine :
Utilisez des plaques à induction, tournez les manches des casseroles vers l'intérieur, évitez l'utilisation des bouilloires



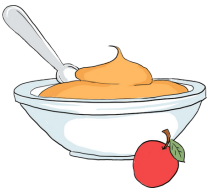
Dans le salon :
mettez un pare-feu devant la cheminée

L'alimentation et les boissons

Il n'existe pas d'aliment dont on peut craindre qu'il provoque ou favorise la survenue de crises épileptiques.



Certaines boissons comme le café ou le thé ont la réputation d'être « excitants » et sont parfois évitées, mais en fait, s'ils sont consommés en quantité raisonnable, il n'existe pas d'argument pour penser qu'ils interfèrent avec le contrôle des crises.



Il existe un régime alimentaire qui présente des effets antiépileptiques propres, c'est le régime cétogène. Il s'agit toutefois d'un régime très particulier réservé pour certains types d'épilepsie, surtout en pédiatrie.

L'apport calorique principal repose sur l'apport en graisse (les lipides) au détriment des sucres (les glucides). Il doit donc se faire sous surveillance médicale stricte et avec l'aide d'une équipe entrainée, car il comporte des risques de carences.



Concernant la prise d'alcool, elle n'est pas complètement interdite, mais elle doit rester très raisonnable.

Dans le cadre d'une maladie épileptique traitée avec des médicaments, il convient de souligner certaines recommandations importantes :

Il ne faut surtout pas arrêter le traitement en vue d'une occasion festive, car tout se cumule alors pour déclencher une crise : abus d'alcool, manque de sommeil et parfois oubli du traitement.

La consommation d'alcool peut augmenter les effets indésirables des médicaments.

Le sommeil

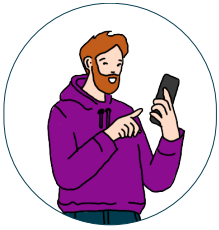


Depuis l'antiquité, nous savons qu'il existe une relation réciproque entre le sommeil et l'épilepsie. Ainsi, les crises ont souvent plus de risque de se manifester lorsque vous manquez de sommeil ou que votre sommeil est de mauvaise qualité.

Quelques recommandations à ce sujet :



- Si vous prévoyez de vous coucher plus tard que d'habitude, essayez de prévoir une sieste dans la journée ou une grasse matinée le lendemain.



- Limiter le temps d'exposition aux écrans et les excitants, surtout en soirée car ils peuvent retarder votre endormissement et/ou nuire à la qualité de votre sommeil.



- Parfois, la durée et la qualité de votre sommeil peuvent être altérées par différentes pathologies tels qu'un syndrome d'apnée du sommeil (ronflement associé à des pauses respiratoires) ou un syndrome de jambes sans repos (les « impatiences »). Dans ce cas, il faudra en parler avec votre médecin. Le traitement de ce type de pathologie peut aider pour diminuer la fréquence de vos crises.

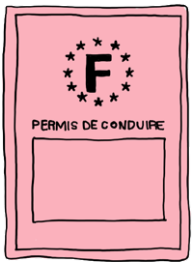
La conduite



Sauf cas particulier, la conduite n'est pas autorisée pendant un an après la survenue de la dernière crise.

Après un an, si vous n'avez pas présenté de nouvelle crise, que les EEG sont sans anomalie et le traitement antiépileptique bien suivi, votre neurologue vous dira s'il est favorable à votre reprise de la conduite.

Vous devrez alors prendre rendez-vous auprès du médecin agréé de votre préfecture qui décidera de façon légale si cette reprise est effectivement possible.
En attendant, pour votre sécurité, il est préférable de s'organiser en utilisant les transports en commun, le covoiturage ou la marche à pied.



Les loisirs

- **L'activité physique**

Elle est recommandée et dans certains cas, peut avoir un réel bénéfice sur la fréquence des crises et le vécu de l'épilepsie avec l'amélioration des symptômes d'anxiété, de dépression ou d'altération de l'estime de soi.

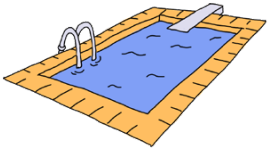
Seuls certains sports sont véritablement contre-indiqués :

- la plongée sous-marine
- les sports de combat
- les sports mécaniques
- les sports aériens.



Des précautions de sécurité sont à prendre pour d'autres :

- sports nautiques : port de gilet de sauvetage et/ou accompagnement (piscine autorisée sous surveillance)
- vélo : port du casque.





Les activités de bien-être type yoga, méditation, relaxation ou encore sophrologie sont quant à elles, toutes recommandées



- **Les sorties**

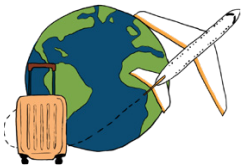
L'épilepsie ne doit pas être considérée comme un frein à la vie en société. Il est tout à fait possible de sortir entre amis dans les lieux que l'on souhaite lorsque l'on est conscient de sa pathologie et de préférence, en ayant informé l'entourage du comportement à adopter en cas de crise.



Il est également envisageable de sortir en discothèque ou dans des lieux à forte luminosité, si vous ne souffrez pas d'une épilepsie photosensible. Mais, gardez à l'esprit que la discothèque est un lieu, bruyant et fatiguant, qui associé au manque de sommeil et/ou à l'abus de boissons peut favoriser la survenue d'une crise d'épilepsie. De même, il est possible de dormir hors de son domicile. Simplement, **il faut penser à prendre son traitement avec soi et informer les accueillants sur l'attitude à adopter en cas de crise.**

- **Les voyages**

Sauf cas particulier (à rediscuter avec le médecin), il n'y a pas de restrictions particulières concernant les voyages du moment que les consignes de sécurité de base sont respectées.



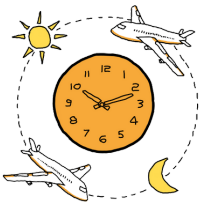
Quelques précautions à prendre :



- Avoir sur soi un document stipulant que vous souffrez d'une épilepsie, qui contacter en cas de problème et quelle est la conduite à tenir en cas de crises.



- Garder ses médicaments sur soi pendant le voyage en avion (pas dans la soute à bagages), en quantité suffisante pour la durée du voyage (voire en plus grande quantité en cas de problème de transport). Se munir de sa dernière ordonnance et du dernier compte-rendu de consultation.



- Décaler progressivement ses horaires de prise de médicaments de 2 heures en 2 heures jusqu'à atteindre l'horaire du pays de villégiature (cette organisation peut être difficile : n'hésitez pas à en discuter avec le médecin ou l'IPA).

- Ne pas voyager seul si vos crises sont trop fréquentes ou susceptibles de vous mettre en danger.

La vie professionnelle



Très souvent, concilier vie professionnelle et épilepsie ne représente pas de problème particulier. Mais parfois, suivant la stabilité de votre épilepsie ou votre type de travail, certains aménagements de poste seront nécessaires (aménagement des horaires de travail ou limitation de la conduite par exemple).

Certaines professions seront déconseillées ou même interdites par la réglementation:

- Activités sur des machines dangereuses,
- Conduite de véhicules professionnels ou transportant du public,
- Travail en hauteur,
- Travail nécessitant un port d'armes,
- Travail isolé sans possibilité de secours rapide.



En dehors de ces activités bien précises, vous n'êtes pas tenu de déclarer votre épilepsie à votre employeur.
Toutefois, il est recommandé d'en parler à votre médecin du travail qui pourra vous aider dans l'adaptation de vos conditions de travail. C'est un interlocuteur privilégié qui respectera le secret médical. De même, il peut être utile d'informer certains collègues proches, sous le sceau de la confidence, afin qu'ils sachent réagir en cas de crise.

Vous pouvez également vous faire reconnaitre comme travailleur handicapé (RQTH). Cela pourra faciliter votre embauche ou si vous êtes déjà employé, vous donner droit à certaines formations.
Si travailler n'est effectivement pas possible, la reconnaissance de votre handicap par la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) vous permettra de percevoir une allocation.

Femme et épilepsie

Etre une femme et souffrir d'une épilepsie nécessite d'être attentive à certains aspects particuliers de la prise en charge :

- Concernant la contraception, elle devra être choisie en accord avec votre neurologue et votre gynécologue. En effet, certains traitements antiépileptiques peuvent altérer son efficacité. Inversement, certaines contraceptions peuvent rendre votre traitement antiépileptique moins efficace. Il faudra donc en discuter avec les médecins qui vous suivent.

- Une grossesse devra toujours être planifiée. Pourquoi ? Certains traitements sont incompatibles avec une grossesse car ils peuvent provoquer des malformations chez le fœtus ou entrainer le développement de troubles cognitifs ou autistiques dans l'enfance.



Si vous souhaitez avoir un enfant, parlez-en avec votre médecin assez tôt. Il vous indiquera si votre traitement, ainsi que la stabilité actuelle de votre épilepsie, permettent d'envisager une grossesse en toute sécurité, pour vous et votre enfant à venir.

Si ce n'est pas le cas pour le moment, vous pourrez rediscuter ensemble des alternatives pour que votre projet puisse se concrétiser dans les meilleures conditions possibles.



- Si vous débutez une grossesse sans qu'elle n'ait été planifiée, prévenez immédiatement votre neurologue pour connaitre la conduite à tenir. Une surveillance plus régulière sera peut-être nécessaire pour votre sécurité et celle de votre futur enfant.

ÉPILEPSIE ET VIE QUOTIDIENNE

Mes notes sur la séance



Séance 3
LE TRAITEMENT ANTI-ÉPILEPTIQUE

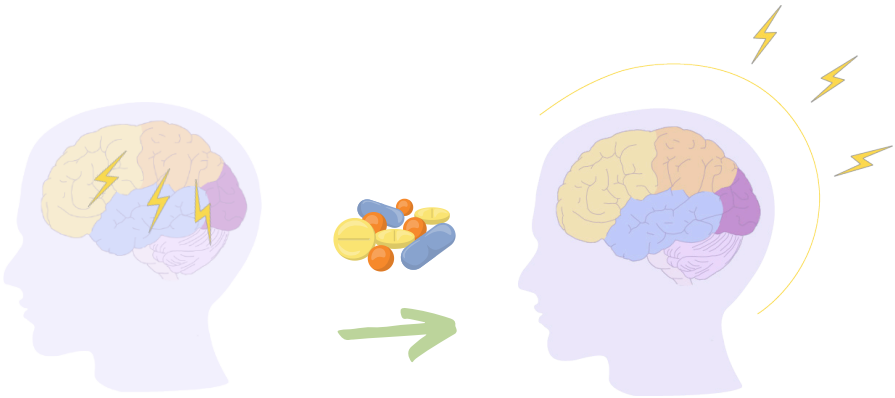
Comprendre et savoir gérer ses médicaments anti-épileptiques



Le **traitement médicamenteux** est le traitement de base contre l'épilepsie.

Les traitements antiépileptiques ne guérissent pas l'épilepsie, mais ils réussissent souvent à réduire ou même à arrêter la survenue de crises en modifiant l'activité des neurones dans le cerveau.

Ce traitement a pour objectif de restaurer un équilibre chimique dans le cerveau, pour limiter ou stopper les décharges électriques excessives à l'origine des crises. Les traitements antiépileptiques agissent comme un « PARA-ORAGE » ou un « PARA-TONNERRE ».



Epilepsie = « Orage » dans le cerveau
Message électrique
++++

MÉDICAMENTS contre l'épilepsie
= « para-orage »
= « para-tonnerre »

Il existe plusieurs formes d'épilepsie donc plusieurs options de traitements sont possibles, associant une ou plusieurs molécules. Dans plus de la moitié des cas d'épilepsie, les crises peuvent être maitrisées grâce à une monothérapie, c'est-à-dire par l'administration d'un seul médicament. Dans d'autres cas, une polythérapie, ou l'administration de plus d'un médicament, sera nécessaire.

Attention, l'interruption passagère ou définitive des antiépileptiques peut provoquer de sérieuses complications, tel qu'un état de mal épileptique, c'est-à-dire un état de crise continue qui peut mettre la vie en danger.

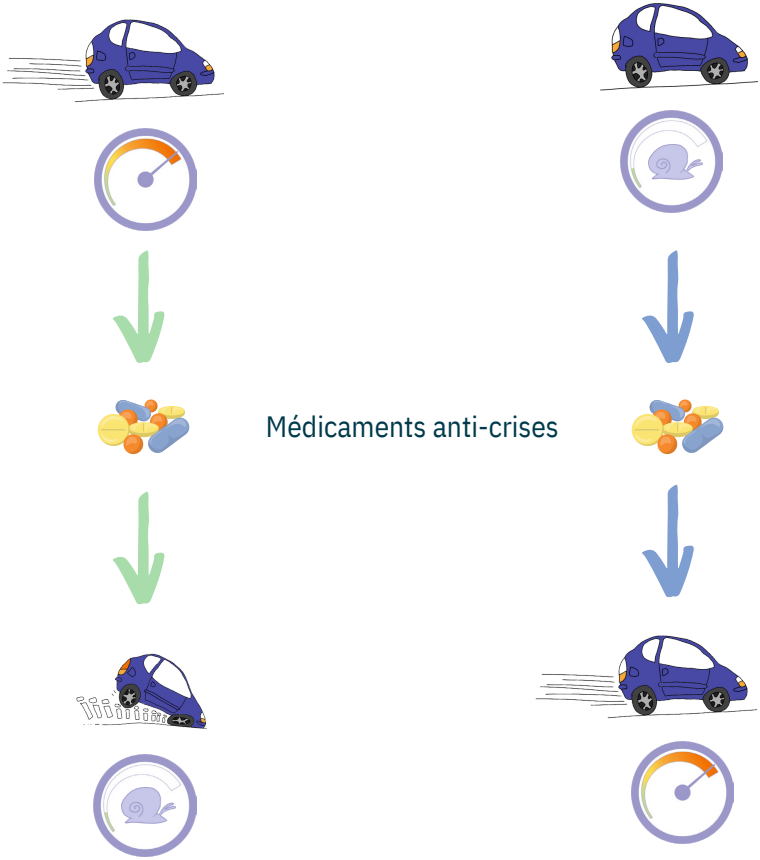
L'arrêt temporaire ou définitif d'un antiépileptique ne doit se faire que sur la recommandation et sous la supervision d'un médecin

Comment fonctionnent les médicaments ?

Les messages envoyés par le cerveau sont transportés le long des neurones sous forme électrique et passent d'un neurone à l'autre par des substances chimiques au niveau des synapses. Ces substances ou neurotransmetteurs jouent un rôle de frein (inhibiteur) ou d'accélérateur (activateur) du message.

NEURONES ACTIVATEURS
de la transmission du
message électrique

NEURONES INHIBITEURS
de la transmission du
message électrique



Médicaments anti-crises

Lutter contre l'action des
NEURONES ACTIVATEURS
du message électrique
= Diminuer/freiner le flux activateur

Favoriser l'action des
INHIBITEURS du message
électrique
= Augmenter/booster le flux inhibiteur

Quelques messages clés sur le traitement antiépileptique

SOYEZ CONVAINCU(E) DE L'IMPORTANCE DE VOTRE TRAITEMENT !

Pour 70% des patients, le traitement antiépileptique permet d'être complétement **libre de crises**. Pour d'autres, il **en diminue la fréquence**, mais aussi la **gravité**. Le traitement antiépileptique est donc l'un des outils essentiels pour pouvoir réaliser en toute sécurité des projets de vie importants comme travailler, étudier, passer son permis de conduire ou encore partir en voyage.

Il peut être difficile de **rester motivé(e)** dans le temps pour prendre son traitement tous les jours sans interruption.
Pour se motiver, vous pouvez mettre en place un système de « récompenses ». Par exemple, tous les 3 à 6 mois, envisager un achat, une fête...

N'arrêtez jamais votre traitement seul si vous ne faites plus de crises d'épilepsie. Si elles ont disparu, c'est parce que le traitement est efficace. En cas d'arrêt, elles risquent de réapparaitre. Dans tous les cas, parlez-en avec votre médecin.

Il est important **d'informer son médecin si l'on a des difficultés à prendre correctement ses médicaments (effets indésirables, oublis, etc.)**. Une discussion est toujours possible sur ce sujet afin d'adapter au mieux votre traitement. Dans le cas contraire, il risquerait de changer à tort un traitement potentiellement efficace.

Ne pas regrouper les prises médicamenteuses : si elles sont réparties sur la journée, c'est pour garantir une efficacité continue.

ORGANISEZ AU MIEUX VOTRE TRAITEMENT DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Pour éviter les oublis, créez une **routine autour de la prise des médicaments** (sonnerie de portable, pense-bêtes, application sur le smartphone, pilulier, etc.).

Adaptez votre prise de médicaments à votre **rythme de vie**. N'hésitez pas à en discuter avec votre neurologue pour trouver des solutions

Soyez vigilant sur certaines situations qui peuvent favoriser les oublis : gestion du traitement durant les week-ends ou les vacances, invitations inopinées etc.)

Trucs et astuces

Conservez des médicaments de « secours » dans votre sac à main, portefeuille, dans le vide-poche de la voiture (attention aux températures élevées l'été), sur votre lieu de travail etc.)

Mes astuces :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

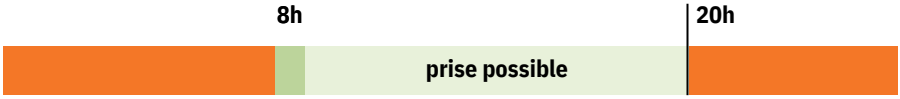
Des situations de gestion du traitement dans la vie quotidienne vous sont présentées en séance d'ETP. C'est l'occasion d'échanger sur la manière de réagir et de partager vos expériences.

J'ai oublié de prendre mon médicament, que dois-je faire ?

En cas d'oubli de prise de médicaments

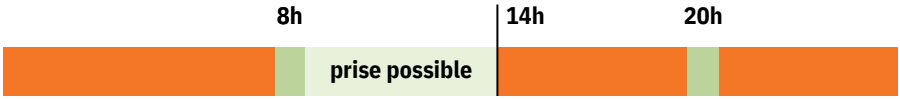
Les oublis doivent rester **exceptionnels**. Si cela se produit, voici un moyen mnémotechnique simple pour vous orienter sur la marche à suivre :

- Je prends mon comprimé une fois toutes les 24h : si je m'aperçois de l'oubli moins de 12h par rapport à l'heure de la prise théorique, je prends le(s) comprimé(s). Sinon j'attends la prise suivante.



ex : prise habituelle 1 fois par jour à 8h

- Je prends mon comprimé toutes les 12h : si je m'aperçois de l'oubli moins de 6h par rapport à l'heure de la prise théorique, je prends le(s) comprimé(s). Sinon j'attends la prise suivante.



ex : prises habituelles 2 fois par jour à 8h et 20h, oubli de celle de 8h

Il est conseillé de toujours avoir une dose de médicament sur soi pour pallier les imprévus, mais aussi d'anticiper son renouvellement d'ordonnance afin d'éviter les arrêts de traitement.

En cas d'oubli de prise de médicaments

J'ai vomi juste après ma prise médicamenteuse

- Je vomis plus d'1h après la prise, je ne reprends pas le(s) comprimé(s)

- Je vomis moins d'1h après la prise, je reprends le(s) comprimé(s)

Organisation des voyages

Je pars en vacances, comment m'organiser pour les médicaments ?

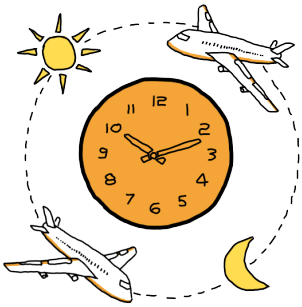
Je prends avec moi une **quantité plus importante de médicaments** que la stricte durée du voyage pour pallier les imprévus.

Documents : Je prends avec moi le compte-rendu de ma dernière consultation, mon **ordonnance**, ainsi que ma **carte vitale** (en France), ma **carte européenne d'assurance maladie** (en Union Européenne) ou mon **assurance privée** (hors Europe).



Voyage en avion : je transporte mes médicaments dans mon **bagage cabine** avec un double de l'ordonnance.

Décalage horaire : Tenir compte des décalages horaires pour le traitement et demander conseil au spécialiste en cas de décalage horaire. Un planning pourra être établi avec l'équipe d'ETP ou le neurologue pour le 1er voyage avec décalage horaire important.



Pour un séjour en France, si j'ai oublié de prendre mes médicaments et mon ordonnance, j'ai des solutions. En contactant ma pharmacie habituelle, mon médecin traitant ou mon neurologue, je peux récupérer une ordonnance et me dépanner dans une pharmacie de mon lieu de vacances.

J'ai mal au dos, puis-je prendre un traitement que je possède déjà chez moi ?

Automédication

Il ne faut **pas prendre de traitement sans avis d'un professionnel de santé** (médecin ou pharmacien). En effet, il peut y avoir des interactions entre les traitements anti-épileptiques et d'autres médicaments (ex : antibiotiques, pilule contraceptive etc.).

D'autres médicaments sont plus à risque de déclencher des crises d'épilepsie car ils abaissent le « seuil épileptogène » (ex : Tramadol, certains antibiotiques ou antidépresseurs).

De même, il ne faut pas prendre de produits de phytothérapie ou des huiles essentielles, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il

est sans danger (ex. : pamplemousse, millepertuis, menthe poivrée, etc.). Là aussi, il peut y avoir des interactions délétères entre ces produits et le traitement antiépileptique.

Grossesse et traitements

Puis-je envisager une grossesse avec mon traitement ?

Attention certains traitements contre l'épilepsie sont **contre-indiqués** au cours de la **grossesse**. En cas de projet de grossesse, **il est impératif d'en parler à son neurologue** pour envisager une modification de traitement si nécessaire.

Les différents médicaments antiépileptiques

Il existe de nombreux médicaments permettant de traiter et prévenir les crises d'épilepsie. Le neurologue vous prescrit ceux qui sont le plus appropriés selon le type d'épilepsie dont vous souffrez, en tenant compte de votre **âge**, de votre **sexe**, des **potentiels effets indésirables**, des éventuelles **autres pathologies** dont vous pourriez souffrir, mais aussi des autres **médicaments associés**.

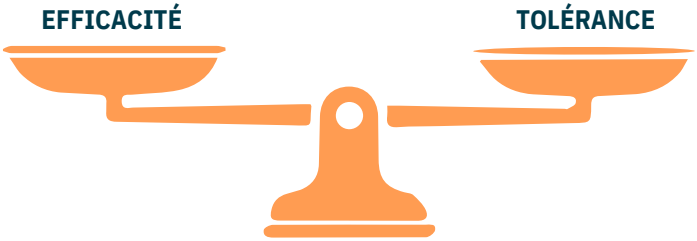
Lors de la mise en place d'un nouveau médicament, les effets indésirables possibles vont seront expliqués par le neurologue car certains sont spécifiques : par exemple effet sur le moral (Levetiracetam…), sur la vision (Lacosamide…), fatigue importante (Cénobamate…), réaction cutanée (Lamotrigine). Pour certains, ils nécessitent une surveillance particulière (prise de sang).

Trouver le traitement médicamenteux le plus adapté peut parfois prendre un certain temps.

Tenez un **journal de vos crises** et des circonstances de leur survenue.
Notez toutes les **questions** que vous pouvez vous poser en lien avec le **traitement** (exemple : potentiels effets indésirables ressentis).
Cela aidera votre neurologue à adapter au mieux votre traitement antiépileptique.

Il est fréquent que le médecin doive **adapter le traitement** (augmentation ou diminution des doses, changement de molécule) **pour parvenir à équilibrer la maladie.**

Les **effets indésirables sont variables d'une personne à l'autre**. Il peut s'agir d'effets transitoires, en début de traitement. Dans certains cas, on augmente la dose progressivement pour éviter ces problèmes.



Médicaments génériques, MTE et substitution

Pour la majorité des patients, le médicament générique a autant d'efficacité que le médicament original. Mais des différences minimes peuvent modifier les effets du traitement chez certains patients, en particulier dans le cas des médicaments à Marge Thérapeutique Étroite (MTE). Certains antiépileptiques sont des médicaments MTE.

Si le traitement a été initié avec le médicament original, il est préférable de poursuivre avec celui-ci.
Si le traitement a été initié par le médecin avec la prescription d'un générique, il est recommandé de poursuivre avec ce même générique, issu du même laboratoire.
Si votre médecin le juge nécessaire, il précise la mention « Non substituable MTE » sur l'ordonnance. Cette mention permet au pharmacien de ville de vous dispenser le médicament original uniquement et non le générique.

Mais en cas de pénurie de traitement, mieux vaut la substitution que la rupture de traitement.

Les traitements non médicamenteux

Le traitement médicamenteux est efficace dans 70% des cas. Dans les 30% de cas restant, on parle de **pharmacorésistance**. D'autres traitements peuvent alors parfois être proposés :

- **La chirurgie**

Le principe consiste à retirer la zone de cerveau qui génère les crises d'épilepsie. La chirurgie ne s'adresse qu'à certains patients bien définis et quand l'ablation de la zone ne risque pas de perturber des fonctions importantes telles que le langage, la motricité, la vision.... La décision d'une chirurgie de l'épilepsie nécessite la réalisation d'une série d'examens approfondis.

- **La Stimulation du nerf vague**

Le but est de réduire la fréquence des crises par des moyens de stimulation électrique du nerf vague. Ce nerf assure la transmission des messages entre le cerveau et nos organes. La stimulation est réalisée par l'implantation chirurgicale d'une électrode au contact du nerf vague au niveau du cou, et d'un générateur/ stimulateur sous la peau, en dessous de la clavicule.

LE TRAITEMENT ANTI-ÉPILEPTIQUE

Mes notes sur la séance



ÉducÉpi
L'éducation thérapeutique en épilepsie
Conception et réalisation : Constance Tahay
Page de couverture : © Service communication CHRU de Nancy
Édité en Décembre 2024

